

GUÍA ASMA

Recordar que en el día a día podemos usar herramientas que nos faciliten la consulta médica, pero con responsabilidad. En el caso de las plantillas, es nuestro deber modificar según las características e historia clínica de cada paciente para mantener la idoneidad de la atención.

Motivo de consulta: “control programa ASMA”

Enfermedad actual:

Paciente de XXXX años, ocupación XXXX, residente en el barrio XXXX, población general. asiste hoy a control de asma, diagnosticada hace XXXX años. Actualmente en tratamiento con XXXX dosis XXXX puf/inhalaciones cada XXXX. este manejo lo está utilizando hace XXXX tiempo con buena respuesta al mismo.

Refiere que utiliza inhalocámara de forma adecuada lo cual se evidencia en la consulta. refiere síntomas diurnos XXXX días a la semana consistentes en XXXX y nocturnos XXXX días a la semana consistentes en XXXX. Comenta síntomas como: como rinorrea clara, estornudos y prurito nasal. Niega lesiones en piel ni signos de dermatitis atópica. Relata que la última crisis fue hace XXXX, manejada en XXXX. Última hospitalización XXXX. No ha requerido de manejo en uci.

Refiere como factor desencadenante de crisis: XXXX (la exposición al frío, al polvo y a los olores fuertes). niega dificultad para realizar ejercicio. indica que la enfermedad no interfiere con sus actividades diarias.

Vive con XXXX no hay fumadores en casa.

Tiene mascota SI/NO. Viven en casa de material SI/NO, piso de baldosa SI/NO, paredes revocadas SI/NO, sin presencia de humedades SI/NO. No vive cerca de avenidas principales o fábricas SI/NO.

Ya asistió al taller de asma SI/NO, tiene vacuna de la influenza: SI/NO, Fecha de aplicación: XXXX, vacuna de COVID SI/NO, Fecha de aplicación: XXXX dosis: XXXX.

Paraclínicos: Radiografía de tórax con fecha XXXX que reporta: XXXX. Hemograma de fecha XXXX que se interpreta XXXX, espirometría con fecha de XXXX que reporta XXXX. Otros paraclínicos XXXX.

Revisión por sistemas:

Niega cefalea, dolor torácico, disuria, tenesmo, pujo, dolor abdominal, niega lesiones en la piel, niega edema en las extremidades, niega ortopnea, niega disnea paroxística nocturna, niega cianosis distal, niega dolor en las articulaciones.

Antecedentes personales

*Diligenciar y actualizar antecedentes patológicos, farmacológicos, alérgicos, quirúrgicos, gineco-obstétricos. En niños actualizar antecedentes perinatales.

Examen físico

Siempre poner signos vitales completos y **PULSOXIMETRIA**

ESTADO GENERAL

Paciente estable, consciente y orientado, en buenas condiciones generales alerta, activo, sin trabajo respiratorio, no cianosis, no palidez.

CABEZA Y CUELLO

Cabeza simétrica, sin lesiones, sin masas. No se palpan nódulos ni cicatrices. Cuello móvil, simétrico, sin adenopatías, sin ingurgitación yugular. Conducto auditivo externo sin alteraciones, otoscopia membrana timpánica sin abombamiento no secreciones. Rinoscopia sin alteraciones. Ojos con conjuntivas rosadas, escleras anictéricas, mucosa oral hidratada. Amígdalas de tamaño y coloración adecuada sin escurrimiento posterior. Sin lesiones. Buena higiene bucal.

TÓRAX

Simétrico, normoexpansible murmullo vesicular conservado sin sobreagregados, sin retracciones ni tiraje, no crépitos, ni roncus. no se encuentra uso de músculos accesorios. Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos.

GASTROINTESTINAL

Abdomen blando, depresible, sin cicatrices ni deformidades, no aparenta dolor a la palpación, sin masa o megalias, sin hernias, sin signos de defensa abdominal. Puño percusión renal negativa.

GENITOURINARIO

No Evaluado por no relación a motivo de consulta

*en caso de síntomas evaluar y describir

EXTREMIDADES

Simétricas, móviles, eutróficas, sin edema. Sin edema, no cianosis distal.

NEUROLÓGICO

Consciente, alerta, tranquilo, fuerza muscular 5/5, no déficit motor, ni sensitivo

VASCULAR

Pulsos presentes periféricos y femorales presentes y simétricos. Llenado capilar <2 segundos

PIEL

Integra, hidratada, sin lesiones agudas evidentes, sin cianosis, sin ictericia, no palidez mucocutánea, no alergias, no lesiones.

Diagnostico

Diagnostico principal: establecer diagnósticos (J450, J459 o la que aplique al diagnóstico)

Análisis:

Paciente asiste hoy a control de asma. se clasifica como asma: XXXX, controlada. continúa igual manejo con XXXX, Control en XXXX meses con paraclínicos de control XXXX Se direcciona a vacunación y a taller de asma, se dan recomendaciones y signos de alarma por escrito a paciente.

Recomendaciones y Signos de Alarma:

Elimine por completo el hábito de fumar y recuerde que este es el factor que contribuye al empeoramiento de su estado de salud. Lo primero que va a hacer el día de hoy es anotar en una agenda los horarios del día en los cuales fuma, y el número de cigarrillos que está fumando actualmente. Desde hoy hasta dentro de 15 días, va a fumar un cigarrillo menos de los que fumaba hasta el día de hoy. Es decir, si usted venía fumando 10 cigarrillos cada día, a partir de hoy va a fumar solo 9 cigarrillos durante los siguientes 15 días. Sea constante, usted puede hacerlo, es solo un cigarrillo menos que se va a fumar. Para ser efectivo, cada día en la mañana saque los cigarrillos que va a fumar y guarde el resto. Ya sabe que esos que tiene a la mano son los que puede fumar y nada más, así que adminístrelos bien. Al cumplir 15 días con el esquema, quite otro cigarrillo, analizando a cual hora es que no se lo va a fumar. De esta manera haremos una retirada progresiva lenta pero constante de este hábito. Si tiene recaídas, retome al día siguiente el esquema donde lo dejó y continúe, sea persistente, usted es capaz de hacerlo.

Otras recomendaciones: no barrer la casa con escoba (sino con trapeadora). Trapear y sacudir con trapo húmedo. Forrar colchones y almohadas. No tener peluches, libros viejos, tapetes, animales ni ropa de lana. Aspirar la cama y el colchón y lavar las cortinas cada 8 días. Evitar el humo del cigarrillo, aerosoles, desodorantes y cambios bruscos de temperatura. Aprender a reconocer el objeto que le produce alergia y retirarlo. Procurar tener al día las vacunas.

Vigilar los siguientes signos de alarma, ya que si presenta cualquiera de ellos deberá consultar por atención prioritaria de inmediato: fiebre. Empeoramiento de la dificultad respiratoria. Silbido audible a distancia. Movimiento de las fosas nasales al respirar. Encajamiento de las costillas al respirar.

En caso de crisis asmática (se identifica por la presencia de tos, dificultad para respirar y silbidos en el pecho) siga los siguientes pasos: administre salbutamol de la siguiente manera: 2 puff cada 10 minutos por 1 hora (idealmente con inhalocámara). Posteriormente 2 puff cada hora. El segundo día: 2 puff cada 2 horas. El tercer día: 2 puff cada 4 horas. A partir del cuarto día hasta que desaparezcan los síntomas de crisis asmática: 2 puff cada 6 horas. Pida cita prioritaria para que lo revisen y determinen si requiere prednisolona pida cita de control de asma (en la taquilla de enfermería de promoción y prevención): debe decir que tuvo crisis asmática y le explicaron que debía volver al control antes de lo previsto si ello ocurría.

En caso de crisis asmática que considere no mejora en casa y no tiene signos de alarma para acudir urgencias, puede solicitar consulta no programada para manejo de su crisis y determinar si amerita adelantar cita programa de asma.

CONTROL DE CAMBIOS

		<i>Martha Catalina Cardona Arango</i> Dirección general
ELABORA	REVISAR	APRUEBA